

I. Khái niệm cốt lõi về Tiêm an toàn (TAT)

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một mũi tiêm an toàn phải bảo đảm 3 tiêu chí "KHÔNG":

- **Không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm.**
- **Không gây phơi nhiễm cho người thực hiện mũi tiêm.**
- **Không tạo chất thải nguy hại cho người khác và cộng đồng.**

II. 6 Giải pháp tăng cường thực hành Tiêm an toàn

Để bảo đảm an toàn, cơ sở y tế và nhân viên y tế cần thực hiện 6 nhóm giải pháp:

1. **Giảm hoặc loại bỏ các mũi tiêm không cần thiết:** Khoảng 70% mũi tiêm điều trị là không cần thiết và có thể thay bằng thuốc uống. Chỉ kê đơn tiêm khi người bệnh không uống được hoặc thuốc uống không đáp ứng điều trị.
2. **Bảo đảm đầy đủ phương tiện, dụng cụ, thuốc:** Cung cấp đủ bơm kim tiêm vô khuẩn dùng 1 lần, đúng kích cỡ. Trang bị đủ bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, hộp chống sốc và hộp đựng vật sắc nhọn đúng tiêu chuẩn.
3. **Bảo vệ nhân viên y tế:** Tiêm phòng vắc xin viêm gan B cho nhân viên y tế và thiết lập hệ thống báo cáo rủi ro phơi nhiễm nghề nghiệp.
4. **Tăng cường kiến thức:** Tập huấn thường xuyên về TAT, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất thải.
5. **Tăng cường kiểm tra, giám sát:** Giám sát tuân thủ vệ sinh tay và quy trình tiêm truyền.
6. **Thực hành đúng quy trình kỹ thuật tiêm:** Đây là phần quan trọng nhất, bao gồm vệ sinh tay, chuẩn bị xe tiêm và nguyên tắc thực hành.

III. Nguyên tắc thực hành tiêm (Quy tắc "3 Không")

1. Không gây nguy hại cho người bệnh (Người nhận mũi tiêm)

- **Thực hiện "5 đúng":** Đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng đường tiêm.
- **Phòng và chống sốc:** Hỏi tiền sử dị ứng trước khi tiêm, luôn mang theo hộp chống sốc. Theo dõi bệnh nhân 10-15 phút sau tiêm. Nếu có dấu hiệu sốc, ngừng tiêm ngay, cho nằm đầu thấp và tiêm bắp Adrenalin theo phác đồ.
- **Đảm bảo vô khuẩn:** Không pha trộn nhiều loại thuốc vào 1 bơm tiêm, loại bỏ kim tiêm đã dùng chạm bề mặt không vô khuẩn.
- **Sát khuẩn da đúng cách:** Dùng cồn 70% sát khuẩn theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài (đường kính 10cm) và để khô tự nhiên trong 30 giây. **Tuyệt đối KHÔNG** đựng bông gạc thấm cồn lưu trữ trong hộp/lọ vì cồn bốc hơi sẽ không còn tác dụng.

2. Không gây nguy hại cho nhân viên y tế (Người tiêm)

- **Vệ sinh tay (5 thời điểm):** Trước khi tiếp xúc người bệnh, trước khi làm thủ thuật vô khuẩn, sau khi tiếp xúc máu/dịch, sau khi chăm sóc người bệnh, và sau khi đựng chặm vùng xung quanh người bệnh.
- **Tránh phơi nhiễm sắc nhọn:** Dùng gạc bọc đầu ống thuốc khi bẻ. **Tuyệt đối KHÔNG** dùng tay đẩy nắp kim sau tiêm; nếu cần, phải dùng kỹ thuật mức 1 tay. Không tháo rời kim tiêm ra khỏi bơm tiêm bằng tay.
- Bỏ bơm kim tiêm vào hộp kháng khuẩn ngay sau khi tiêm (không để đầy quá 3/4 hộp).

3. Không gây nguy hại cho cộng đồng

- Sử dụng hộp/thùng kháng khuẩn chuẩn để đựng vật sắc nhọn (vỏ cứng, không thấm, có nắp đậy, màu vàng, có vạch cảnh báo).
- Thu gom và tiêu hủy chất thải sắc nhọn đúng theo Quy chế quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế.

IV. Lưu ý quan trọng khi lấy thuốc tiêm

- Thực hiện **4 KHÔNG**: Không dùng 1 bơm kim tiêm cho nhiều bệnh nhân; Không tái sử dụng bơm kim tiêm; Không dùng 1 bơm kim tiêm để pha cho nhiều lọ thuốc; Không dùng lại thuốc thừa.
- Không chạm tay vào pít tông, đầu ăm-bu, hay thân kim tiêm trong quá trình chuẩn bị.
- Không cắm lưu kim tiêm ở lọ thuốc đa liều để lấy thuốc cho những lần sau.